

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN MANAJEMAN AKTIF KALA III DENGAN KOMPLIKASI RETENSIO PLASENTA		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	571.57/I-SPO/MTR/VI/2025	0	1 / 4
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 18 Juli 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Nur Mazidah	
Pengertian	Penatalaksanaan manajemen aktif kala III dengan komplikasi Retensio plasenta adalah suatu tindakan yang dilakukan setelah lahirnya bayi dan plasenta tidak lahir ≥ 30 menit		
Tujuan	1. Bidan RS mampu menganalisa dan memberikan Tindakan pada persalinan dengan komplikasi retensio plasenta 2. Menyiapkan semua perlengkapan alat, obat-obatan dan pasien dengan prolaps tali pusat 3. Bidan mampu memberikan pelayanan asuhan sayang ibu dan bayi selama proses persalinan 4. Menghasilkan uterus yang lebih efektif sehingga dapat mempersingkat waktu, mencegah perdarahan dan mengurangi kehilangan darah pada kala 3 persalinan 5. Menurunkan angka kematian ibu (AKI) akibat HPP		
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025 tentang Pedoman PONEK 24 jam 2. Dilakukan oleh Dokter dan bidan.		
Prosedur	1.1 Persiapan. 1. Alat. 1. Alat pelindung diri 2. Handscoon steril 6,5 3. Handscoon steril gynekologi 4. Under pad 5. Infus set makro 6. Iv line no.18 7. RL 500 cc 8. Sputit 3 cc,10 cc 9. Oksitosin 10 iu 10. Pospargin 1 amp 11. Kasa steril 12. Dekatkan alat ke pasien 2. Siapkan pasien 2.1 Lakukan tindakan dengan 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) 2.2 Perkenalkan diri pada pasien 2.3 Identifikasi pasien (nama , tanggal lahir)Pasien. 2.4 Jelaskan pada ibu tujuan dan prosedur yang akan dilakukan		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN MANAJEMAN AKTIF KALA III DENGAN KOMPLIKASI RETENSIO PLASENTA		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	571.57/I-SPO/MTR/VI/2025	0	2 / 4
	2.5 Atur posisi pasien dalam posisi <i>dorsal recumbent</i> (<i>menekuk lutut dan melebarkan kedua kaki</i>) 2.6 Jelaskan kepada keluarga pasien tujuan, prosedur tindakan dan resiko yang akan di alami ibu saat dilakukan tindakan 3. Siapkan Lingkungan pasien 4. Rincian prosedur tindakan 4.1 Cuci tangan 6 langkah 4.2 Pakai APD sesuai standart (Celemek, masker, <i>google</i>, sepatu boot dan sarung tangan) 4.3 Lakukan pemeriksaan umum dan khusus (tanda lahirnya plasenta dan lakukan MAK III) 4.4 Jika 15 menit plasenta belum lahir : 1. Kosongkan kandung kemih (lakukan caterisasi bila perlu) 2. Suntik ulang oxytosin 10 iu / IM 3. Observasi 15 menit 4. Lakukan PTT ulang 5. Konsul kondisi pasien kepada dokter obgyn 6. Persiapan lakukan Tindakan manual plasenta 4.5 Jelaskan kepada keluarga dan pasien bahwa setelah 30 menit plasenta belum lahir akibat terjadinya retensio plasenta 4.6 Jelaskan tentang tujuan, prosedur tindakan dan resiko yang akan di alami ibu saat dilakukan tindakan Manual Plasenta 4.7 TTD persetujuan keluarga pasien untuk Tindakan Manual Plasenta 4.8 Tatalaksana Tindakan Manual Plasenta. 1. Pasang infus RL 500 cc dan obat obatan (sesuai advis dokter obgyn) 2. Jepit tali pusat dengan klem, tegangkan tali pusat sejajar dengan lantai dengan menggunakan tangan kiri 3. Masukkan tangan kanan secara obstetric kedalam introitus vagina, menelusuri sisi bawah tali pusat sampai ke bagian serviks		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN MANAJEMAN AKTIF KALA III DENGAN KOMPLIKASI RETENSIO PLASENTA		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	571.57/I-SPO/MTR/VI/2025	0	3 / 4
	4. Minta tolong asisten penolong untuk memegangkan klem tali pusat 5. Tangan kiri menahan fundus, pegang tali pusat dengan menggunakan tangan yang lain 6. Masukkan tangan kanan menuju cavum uteri, cari dan temukan implementasi plasenta paling bawah dan tepi plasenta yang telah lepas 6.1 Bila plasenta berimplementasi di korpus belakang,tali pusat tetap di sebelah atas dan siapkan ujung jari tangan di antara plasenta dan dinding uterus dimana punggung tangan menghadap ke bawah (posterior ibu) 6.2 Bila dikorpus depan maka pindahkan tangan ke sebelah atas tali pusat dan sisipkan ujung jari jari tangan di antar plasenta dan dinding uterus dimana punggung tangan menghadap ke atas (anterior) 6.3 Bila tepi plasenta tidak teraba atau plasenta berada di dataran yang sama tinggi dengan dinding uterus maka segera hentikan upaya Tindakan Manual Plasenta karena hal tersebut menunjukkan plasenta inkreta (tertanam dalam myometrium) 6.4 Bila sebagian dari implantasi plasenta dapat dilepaskan sebagian dan bagian lainnya melekat erat maka segera hentikan upaya Tindakan Manual Plasenta karena hal tersebut menunjukkan plasenta Akreta 7. Bentangkan tangan obstetric menjadi datar seperti memberi salam (ibu jari merapat ke jari telunjuk dan jari jari lain saling merapat) 8. Gerakan tangan kanan ke kanan dan ke kiri sambil di geserkan ke atas (kraniel ibu) hingga semua perlekatan plasenta terlepas dari dinding uterus 9. Lakukan eksplorasi untuk memastikan tidak ada sisa selaput placenta yang tertinggal 10. Pindahkan tangan luar dari fundus ke supra sinfisis		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN MANAJEMAN AKTIF KALA III DENGAN KOMPLIKASI RETENSIO PLASENTA		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
	571.57/I-SPO/MTR/VI/2025	0	4 / 4
	(tahan segmen bawah uterus) 11. Instruksikan asisten penolong untuk menarik tali pusat sambil tangan kanan dalam membawa plasenta keluar 12. Lakukan penekanan uterus ke arah dorso kranial 13. Letakan placenta pada tempat placenta yang telah disiapkan 14. Perhatikan kontraksi uterus dan kemungkinan terjadinya perdarahan		
Unit Terkait	1. IGD 2. MATERNITAS		